

- 108★★★★
☑☑☑ ICS 使用後にうがいをするよう勧める。
- 109★★★★
☑☑☑ 吸入時には舌を下げ喉の奥を広げて薬の通り道を広く保つ「ヘー」の発音のような舌の位置を勧める。
- 110★★★★
☑☑☑ 重症喘息で全身ステロイド療法を1年に2回以上必要とする症例では、生物学的製剤の使用を検討する。
- 111★★★★
☑☑☑ 日本では、重症喘息に対して3種類の生物学的製剤が使用可能である。
- 112★★★★
☑☑☑ 重症喘息に対する生物学的製剤はすべての年齢層に適応がある。
- 113★★★★
☑☑☑ 喘息におけるアレルギー免疫療法 (allergen immunotherapy: AIT) は効果が乏しい。
- 114★★★★
☑☑☑ AIT の適応年齢は18歳以上である。
- 115★★★★
☑☑☑ AIT では皮下注射法と舌下法の2種類がある。
- 116★★★★
☑☑☑ ダニ AIT には、喘息症状の改善、気道過敏性の改善、薬物減量効果がある。
- 117★★★★
☑☑☑ AIT の治療は曝露期に開始する。
- 118★★★★
☑☑☑ 喘息の急性増悪（いわゆる発作）の分類において、苦しくて動けない状態は中等度に該当する。
- 119★★★★
☑☑☑ アミノフィリンの主な副作用は、頻脈、動悸、不整脈、振戦、消化器症状である。
- 120★★★★
☑☑☑ 喘息増悪に対する治療開始から数時間以内に症状改善がみられなければ、入院加療を考慮する。
- 121★★★★
☑☑☑ NSAIDs 過敏喘息はアスピリン以外の薬剤では喘息増悪を引き起こさない。
- 122★★★★
☑☑☑ NSAIDs 過敏喘息では、NSAIDs による増悪をきたすだけではなく、コハク酸エステル型ステロイドでも増悪することがある。